UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

CHIRURGIE DIGECTIVE
Péritonite suite à cholécystite
avec patient
sans geste clinique

Nom du rédacteur : FONTAINE Mathilde Date de rédaction : 04/12/2023

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 004 douleur abdominale

– SUJET 1: cholécystite initiale donnant péritonite

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Examen clinique

Domaine de compétence n°2 (en sélectionner 1 SEUL) : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée

→ Caractériser la douleur, l'évolution, son mode d'installation et les signes associés

→ Poser l'indication d'une prise en charge chirurgicale

Patient simulé nécessaire à la station : OUI

> 65 ans / Lieu des soins : hôpital

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard OUI
- matériel nécessaire = stéthoscope

Instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autres que ce qui est précisé.

Synopsis :

Vous avez 68ans, retraitée, ancienne professeure des écoles. Vous avez été hospitalisée hier en service de médecine digestive aigue pour une cholécystite diagnostiquée suite à une douleur en hypochondre droit et une fièvre persistante.
Ce matin vos douleurs abdominales ce sont étendues à l'ensemble de votre abdomen et sont difficilement supportables.
L'interne du service va vous interroger et vous examiner.

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : Michelle Prénom : FRACHI Age : 68ans, retraitée, vit dans une maison avec son mari
Antécédents	AUCUN
Médicamentsactuels/ Toxiques	*Des vitamines le matin, pas de toxiques*
Etats d'esprit/ comportement	Posture : allongée Douleur : forte
Déroulement du scénario	-Vous êtes allongée sur un brancard -Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : ***"Je n'avais plus mal puis la j'ai des douleurs au ventre malgré le doliprane, ça ne passe pas et ça m'a même réveillé cette nuit tellement c'était fort»*** -Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf tableau ci-dessous) et ne dévoilez les info que s'il vous les demande spécifiquement. -Il doit normalement vous examiner. Laissez-vous guider. Lorsqu'il soulève palpera votre ventre vous direz "**aïe ça fait mal**" en contractant vos muscles abdominaux pour mimer une défense/contracture (comme un ventre de bois) -1 min avant la fin, la patiente demandera en quoi consiste la suite de sa prise en charge
Autres questions à poser au médecin, à quel moment	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Avez-vous des diarrhées ?	Oui depuis cette nuit je n'arrête pas d'aller aux toilettes
Avez-vous des glaires, du sang dans les selles ?	NON
Avez-vous des nausées/vomissement ?	J'ai vomis 1 fois ce matin
Continuez-vous d'aller aux toilettes et d'avoir des gazs ?	Oui oui pas de problème
Ou avez-vous mal exactement ?	**Partout mais encore plus ici (en montrant avec son doigt l'hypochondre droit)**
La douleur est apparue brutalement ou progressivement ?	BRUTAL
A combien estimez-vous la douleur sur une echelle de 1 à 10 / a quel point avez-vous mal	8/10 / très intense
C'est une douleur continue ou paroxystique ?	Par pic, paroxystique
Est-ce que qqch calme la douleur ? L'aggrave ?	-> rien -> chaque mouvement
Avez-vous de la fièvre ?	Oui à 39 m'a dit l'infirmière
Trouvez vous que votre teint soit plus jaune que d'habitude ?	NON
Trouvez vous que votre teint soit plus pâle que d'habitude ?	OUI
Avez-vous envie d'aller plus souvent aux toilettes ? est-ce que ça brule quand vous faites pipi ?	NON NON
Avez-vous le hoquet / du mal à respirer	NON
Est-ce qu'on vous a pris les constantes ?	Oui je crois mais c'est-à-dire ? *Et l'examinateur répondra à chaque demande de l'étudiant*
Lorsque l'étudiant inspecte le ventre de la patiente	Il n'y a rien -> pas de cicatrices, pas de distention abdo
Lorsque l'étudiant écoute les bruits hydro aériques avec le sthétoscope	BHA présents
Calcule votre fréquence respiratoire	L'infirmière m'a dit que je respirais très vite par rapport à hier

Calcule votre fréquence cardiaque	L'infirmière à dit que mon cœur battait à 100 à l'heure, c'est énorme non ??

Consignes à l'examinateur

Partie INTERROGATOIRE
→ La patiente répondra à toutes les questions de l'étudiant
→ Si l'étudiant cherche à connaitre les constantes de la patiente, l'examinateur lui demandera ce qu'il souhaite savoir précisement :

- FC à 100
- PA à 137/87
- FR à 20
- Saturation à 98%
- T°C à 39°C malgré le doliprane

Partie EXAMEN PHYSIQUE

→ Lorsque l'étudiant inspecte le ventre de la patiente
- L'examinateur précisera qu'il n'y a rien : pas de cicatrices, pas de distention abdo

→ Lorsque l'étudiant écoute les bruits hydro aériques avec le sthétoscope
- L'examinateur précisera que les BHA sont présents

→ Lorsque l'étudiant palpera l'abdomen de la patiente <u>en précisant qu'il recherche une contracture ou une defense abdominale</u> :
- l'examinateur répondra que l'examen clinique révèle une contracture

→ Lorsque l'étudiant recherchera les **signes de choc** à l'examen cliniques =
- marbrures = NON
- oligurie = NON
- TRC < 3s
- Pas d'hypotension, légère tachycardie
- Pas de confusion

Instructions à l'étudiant

Vous êtes l'interne du service de médecine digestive aigue et êtes appelé par l'infirmière qui vous demande d'aller voir dans la chambre 603 Mme FRACHI Michelle, 68ans, initialement hospitalisée pour des douleurs localisée en hypochondre droit et une fièvre à 39° depuis 4 jours chez qui le diagnostic de cholécystite a été posé à l'échographie.
Cette-dernière est en attente de la cholestyctetomie, elle ne présente par ailleurs aucun antécedents familiaux/chirurgicaux/personnels, ne prend pas de traitement, ne fume pas ne bois pas et n'a aucune allergie connue.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Effectuez l'examen clinique (interrogatoire + examen physique) ciblé de la patiente
2. Enoncez votre suspision diagnostique à la patiente
3. Expliquez au patient en quoi va consister la prise en charge

L'interrogatoire et l'examen clinique général de la patiente ont déjà été effectué à l'entrée de la patiente dans le service, vous n'avez pas à les effectuer à nouveau.

Vous n'aurez pas à réaliser de toucher rectal

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Recherche des nausées et/ou des vomissements à l'interrogatoire	
Recherche une diarrhée à l'interrogatoire	
Recherche un arrêt des gaz ET des matières (tableau d'occlusion/ileus) à l'interrogatoire	
Caractérise la douleur abdominale-> point accordé si 2 parmi -généralisée/diffuse -brutale -intense à 8/10 -vives, paroxystiques -provoquée par le mouvement	
Recherche un syndrome infectieux -> point accordé si 2 parmi -recherche de la fièvre ≥ 38°5 C -recherche/calcule la fréquence respiratoire -recherche/calcule la fréquence cardiaque	
Recherche des signes de choc chez la patiente -> point accordé si 2 parmi = - marbrures - oligurie - TRC < 3s - hypotension - confusion	
Effectue l'examen clinique abdominal cadran par cadran <u>en finissant par l'hypochondre droit</u>	
Relève une défense et/ou contracture généralisée à l'examen abdominal (ventre de bois douloureux invincible à la palpation)	
Tache 2	
Énonce à la patiente le diagnostic de : -péritonite sur rupture de la vésicule biliaire OU -péritonite secondaire à la cholecystite OU -infection du péritoine suite à infection vésicule biliaire *(il faut la notion de péritonite ET le fait qu'elle soit due à la cholecystite pour compter le point)*	

Tache 3	
Explique à la patiente qu'on va lui faire une prise de sang pour effectuer un bilan biologique ET/OU des hémocultures	
Explique à la patiente qu'on va la perfuser pour lui mettre une antibiothérapie OU qu'on va lui changer la perfusion pour mettre d'autres antibiotiques	
Explique à la patiente qu'un scanner abdomino-pelvien est nécessaire	
Explique à la patiente qu'on va l'emmener au bloc opératoire pour une chirurgie	
Propose des antalgiques pour calmer la douleur de la patiente	
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE À QUESTIONNER	1 à 5
APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE	
APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS	